IV Concurso Internacional en Derecho Médico, Bioética y Bioderecho
Caso Valentina y Amalia vs. Avelia

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ACLARATORIAS

Bogotá D.C., septiembre 25 de 2026

CONSIDERACIONES GENERALES

- Las presentes respuestas forman parte integral del caso hipotético. En caso de contradicción, prevalece la respuesta aclaratoria.
- Las respuestas fijan hechos; no resuelven cuestiones jurídicas. La calificación jurídica y el alcance de los hechos corresponde a los equipos participantes.
- Cuando una respuesta indica que algo "no consta en el expediente", no podrá suplirse con hechos inventados. Los equipos sí podrán argumentar sobre las consecuencias de esa ausencia de prueba, en los términos del artículo 22 Bis del Estatuto de Barcelona (EB) sobre carga argumentativa.
- El derecho aplicable se rige por el artículo 20 EB.

I. MARCO JURÍDICO DEL ESTADO DE AVELIA

1. ¿El ordenamiento jurídico de Avelia es equivalente al colombiano y a su bloque de constitucionalidad? ¿Su contexto económico, fiscal y social puede asimilarse al de Colombia?

No. Avelia es un Estado ficticio y su ordenamiento es el descrito en el caso, en el Estatuto de Barcelona y en estas respuestas. El derecho colombiano, incluida la jurisprudencia de la Corte Constitucional, no es derecho interno de Avelia. Solo podrá invocarse como derecho comparado o como fuente de principios generales, en los términos del artículo 20.1.c EB.

Para efectos del concurso se precisa lo siguiente:

- Avelia ratificó sin reservas la CEDAW, la CDPD y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
- Avelia ratificó el Convenio 189 de la OIT. No ha ratificado el Convenio 156 de la OIT.
- Avelia aceptó la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1985.
- Su Constitución contiene una cláusula de incorporación de los tratados de derechos humanos ratificados. La Corte Suprema ha reconocido esa cláusula, pero no ha definido en su jurisprudencia el valor de las opiniones consultivas de la Corte IDH.

En lo económico y social, Avelia es un país de ingreso medio-alto con déficit fiscal persistente. Su sistema de salud atraviesa presiones financieras documentadas. El gasto público en salud equivale aproximadamente al 6,5% del PIB. No pueden importarse cifras concretas de Colombia distintas de las que constan en el caso o en estas respuestas.

2. ¿Tiene Avelia regulación específica sobre interfaces cerebro-computador (BCI) o neurotecnología experimental? ¿Hay precedentes judiciales sobre el cuidado como derecho autónomo o sobre protocolos de neurotecnología experimental?

Sobre regulación:

- Avelia tiene regulación general sobre investigación biomédica con seres humanos. Exige aprobación de un Comité de Ética en Investigación y autorización de la agencia sanitaria para dispositivos en fase de investigación.
- No existe regulación específica sobre interfaces cerebro-computador, neurotecnologías ni neuroderechos, ni sobre la protección de datos neuronales.
- Tampoco existe norma que regule las obligaciones del promotor de un ensayo frente a cuidadores o terceros que intervienen en su ejecución.

Sobre precedentes:

- Algunos jueces de instancia han ordenado prestaciones puntuales de apoyo, como insumos, transporte o, excepcionalmente, auxiliares de enfermería.
- No existe una línea jurisprudencial consolidada.
- La sentencia de la Corte Suprema del 14 de enero de 2026 es el primer pronunciamiento de cierre sobre el cuidado como derecho autónomo.
- No hay precedentes judiciales sobre neurotecnología experimental.

II. SITUACIÓN CLÍNICA DE AMALIA Y CUIDADO REQUERIDO

3. ¿Cómo cambió la salud de Amalia desde el diagnóstico (enero de 2023) hasta la renuncia de Valentina (2024)?

- **Primer semestre de 2023:** debilidad progresiva en las extremidades superiores, disartria leve, y primeros cambios conductuales y de juicio asociados a la demencia frontotemporal. Conservaba autonomía parcial.
- **Segundo semestre de 2023:** pérdida de la marcha independiente, disfagia moderada, y necesidad de ayuda en higiene, vestido y alimentación. Valentina redujo su jornada laboral.
- **Primer semestre de 2024:** se inicia ventilación no invasiva nocturna y se indica alimentación por gastrostomía. Aparecen episodios de desorientación alternados con ventanas de lucidez.
- **Septiembre y octubre de 2024:** dependencia total para las actividades básicas e instrumentales, con necesidad de vigilancia nocturna por la ventilación. Valentina renuncia a su empleo en octubre de 2024.

4. ¿Qué tipos de cuidado requiere la enfermedad de Amalia?

La enfermedad requiere cuatro niveles de cuidado:

- **Cuidado asistencial básico:** higiene, movilización, cambios de posición, alimentación por gastrostomía y acompañamiento. Puede prestarlo un cuidador no profesional capacitado.

- **Cuidados técnicos:** manejo del equipo de ventilación no invasiva, aspiración de secreciones y prevención de úlceras por presión. Requieren entrenamiento, pero no necesariamente un profesional.
- **Atención médica especializada:** neurología, neumología, nutrición, rehabilitación y psicología. Está cubierta por el Plan de Beneficios y la EPS la presta, con demoras ocasionales.
- **Cuidados paliativos:** disponibles en la red de la EPS.

La exclusión de la Resolución 512 recae sobre el primer nivel, el cuidado asistencial básico o "cuidador".

5. ¿El posoperatorio de la implantación de la interfaz exige un cuidado especializado o clínico? ¿Qué tan riguroso debe ser y tiene que prestarlo un profesional de la salud?

El protocolo tiene dos componentes:

- **Componente clínico:** diez días de hospitalización en el Instituto tras la cirugía, y luego controles presenciales y monitoreo remoto del implante. Lo presta el equipo profesional del Instituto.
- **Componente domiciliario de estimulación:** 16 horas diarias durante 18 meses, con ejercicios físicos y cognitivos guiados por software. Incluye registro diario de datos y alertas ante signos de neuroinflamación.

El componente domiciliario no exige un profesional de la salud. Sí exige una o varias personas que hayan aprobado la capacitación del Instituto, un curso de 40 horas con evaluación. El manual exige apego estricto: la omisión de sesiones durante más de 48 horas se considera un factor de riesgo de falla del implante.

El manual recomienda la rotación de al menos dos personas capacitadas. Sin embargo, esa rotación no es un requisito de elegibilidad.

6. ¿En qué se diferencia el cuidado que Amalia recibe hoy de Valentina, en tipo y en tiempo, del que exige el protocolo?

Hoy Valentina presta cuidado asistencial básico y técnico durante unas 14 a 16 horas diarias. Además atiende interrupciones nocturnas relacionadas con la ventilación. No tiene capacitación formal, descanso regular ni reemplazo.

El protocolo introduce diferencias de tipo y de tiempo:

- **En tipo:** exige estimulación neuroespecífica estructurada, registro de datos y detección de alarmas clínicas. Es un cuidado distinto al actual.
- **En tiempo:** las 16 horas son de acompañamiento activo en vigilia, en bloques. Dentro de ellas pueden integrarse parcialmente las actividades básicas, pero la vigilancia nocturna sigue siendo adicional.

Por eso la carga total sería superior a la actual. El protocolo no cuantifica esa carga total.

7. ¿Hay otras alternativas terapéuticas o experimentales para Amalia, o instituciones con protocolos de estimulación posoperatoria distintos del domiciliario exclusivo de 16 horas diarias?

Sobre alternativas terapéuticas:

- En Avelia no existe otro protocolo de BCI para ELA.
- El tratamiento convencional está disponible y cubierto: fármacos modificadores de la enfermedad, ventilación no invasiva, gastrostomía, rehabilitación y cuidados paliativos. Ese tratamiento no restaura la comunicación ni la motricidad fina.

Sobre modalidades distintas:

- El Instituto no ofrece modalidad hospitalaria ni mixta. Su justificación es que la plasticidad del implante requiere entorno ecológico doméstico, con base en evidencia preclínica.
- El comité científico discutió una modalidad de menor intensidad, de 10 horas diarias, pero la descartó por insuficiencia de datos.

Sobre protocolos en el exterior:

- En el exterior existen ensayos de fase I con BCI de tecnología distinta, sin nanotransmisores biológicos. Uno tiene componente hospitalario.
- Esos ensayos exigen residencia en el país sede o financiación propia.
- No consta que Amalia sea elegible ni que se haya solicitado su remisión al exterior.

III. PROYECTO MNEMÓSINE

8. ¿El Proyecto Mnemósine es un protocolo de investigación biomédica con seres humanos o un tratamiento asistencial de uso compasivo o expandido?

Es un protocolo de investigación biomédica con seres humanos, un ensayo clínico de fase I/II de seguridad y eficacia preliminar. No es un tratamiento asistencial de uso compasivo ni de acceso expandido. Amalia participaría como sujeto de investigación, aunque el protocolo tiene intención terapéutica.

9. ¿El Proyecto Mnemósine fue autorizado como uno de los "ensayos o protocolos especiales" de la excepción prevista en la Resolución 512?

No. En noviembre de 2025 el Instituto pidió al Ministerio de Salud que el proyecto se considerara un "protocolo especial debidamente autorizado" para efectos de esa excepción.

A la fecha de la audiencia, el Ministerio no ha decidido de fondo. Solo ha respondido que la excepción carece de reglamentación y que no existe un procedimiento para tramitarla.

10. ¿El protocolo fue evaluado por un Comité de Ética en Investigación? ¿Ese comité se pronunció sobre los riesgos para Amalia y para Valentina?

Sí. El protocolo fue aprobado en 2024 por el Comité de Ética en Investigación del Instituto, que está registrado ante la autoridad nacional. La agencia sanitaria autorizó el dispositivo para uso en investigación.

El Comité evaluó los riesgos para la participante. Frente al cuidador, solo exigió la suscripción de un documento de compromiso. No evaluó su estado de salud ni la proporcionalidad de la carga.

La advertencia sobre la "doble tensión" provino después del comité científico y de la Junta Médica, que son órganos distintos del Comité de Ética. El Comité de Ética no ha reevaluado el protocolo después de esa advertencia.

11. ¿Qué riesgos, beneficios y compensaciones fija el protocolo, y cuáles se dirigen a los cuidadores? ¿Qué decía el consentimiento sobre esos riesgos y cómo se pensaba compensarlos?

Riesgos para la participante:

- Infección, hemorragia y crisis convulsivas.
- Neuroinflamación, que puede ser fatal.
- Falla del implante y necesidad de explantación.
- Riesgos desconocidos propios de una tecnología en investigación.

Por el reducido número de participantes, el protocolo no cuantifica con precisión estos riesgos.

Beneficios esperados:

- Restauración parcial de la comunicación y de la motricidad fina.
- El implante no detiene ni revierte la progresión de la ELA.

Compensaciones:

- **Para la participante:** dispositivo, cirugía, hospitalización, controles, transporte a los controles y póliza de responsabilidad.
- **Para los cuidadores:** ninguna compensación económica. Solo capacitación gratuita y una línea de apoyo técnico.

Sobre el consentimiento:

- El consentimiento informado de Amalia mencionaba de forma genérica la necesidad de "acompañamiento domiciliario intensivo por familiar o cuidador".
- En mayo de 2025 Valentina firmó una "carta de compromiso del cuidador principal". En esa fecha la Junta Médica aún no había fijado la condición de 16 horas diarias durante 18 meses.
- Ningún documento previó cómo mitigar o compensar los riesgos para la persona cuidadora.

12. ¿El Proyecto Mnemósine cubre todos los costos del implante, la hospitalización, los controles y el seguimiento médico, o solo la interfaz?

El proyecto cubre:

- La interfaz y la cirugía.
- La hospitalización posoperatoria.
- Los controles y el seguimiento del implante durante 18 meses.

- La explantación, si fuera necesaria.

El proyecto no cubre:

- El cuidado domiciliario de 16 horas.
- La atención de la ELA de base.
- Las complicaciones que excedan la capacidad del Instituto, que quedarían a cargo de la EPS.

13. ¿Cuántas personas han participado en el protocolo, en qué fase se encuentra y cuántos casos de éxito tiene?

- El protocolo está en fase I/II y comenzó en 2024.
- Seis personas han recibido el implante en Avelia. Amalia sería la séptima.
- Cuatro presentan mejoría medible en comunicación. Esos resultados son preliminares y no han sido publicados en revistas arbitradas.
- Un participante requirió explantación por infección.
- Un participante se retiró voluntariamente.
- No se han reportado muertes.
- El protocolo no define qué se considera "éxito".

14. ¿El protocolo tiene aprobaciones o estudios en otros países?

No. El componente de nanotransmisores biológicos es propiedad del Instituto y no tiene aprobación regulatoria en ningún país. Existen estudios preclínicos propios y publicaciones sobre tecnologías BCI relacionadas pero no idénticas.

15. ¿Los cuidadores de los demás participantes también se financian por su cuenta? ¿Son hombres o mujeres?

Sí, todos se financian por su cuenta:

- **Cuatro participantes** reciben cuidado de familiares no remunerados: tres mujeres (dos hijas y una esposa) y un hombre (un esposo).
- **Dos participantes** contrataron cuidadores privados con recursos propios. Pertenecen a hogares de ingresos altos.

IV. CONSENTIMIENTO Y REPRESENTACIÓN DE AMALIA

16. ¿Por qué el consentimiento de Amalia se otorgó ante notario? ¿Fue una expresión de voluntad anticipada o el consentimiento informado? ¿Qué alcance tiene la expresión "no quiero ser una carga para mi hija"?

Hay dos documentos distintos:

- **El consentimiento informado del protocolo.** Se firmó en el Instituto, en formato estándar, durante una ventana de lucidez certificada por la médica tratante.

- **Una declaración notarial de voluntad anticipada.** Amalia la otorgó por iniciativa propia y por recomendación de su médica, ante el riesgo de perder capacidad de manera permanente. La médica tratante estuvo presente.

La declaración notarial contiene este texto:

> *"Es mi voluntad acceder al implante del Proyecto Mnemósine y a los tratamientos que me permitan comunicarme. Al mismo tiempo, no quiero ser una carga destructiva para mi hija Valentina."*

El documento no precisa las consecuencias jurídicas de esa frase ni establece una jerarquía entre ambas manifestaciones. Su interpretación corresponde a los equipos.

17. ¿Bajo qué figura jurídica actúa Valentina como representante legal de Amalia?

Avelia abolió la interdicción en 2021 y adoptó un régimen de apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica.

En 2024 un juez de familia adjudicó a Valentina la calidad de persona de apoyo, con facultades de representación en asuntos de salud y actos jurídicos. Esas facultades aplican en los periodos en que Amalia no pueda expresar su voluntad, y debe respetarse la voluntad expresada en las ventanas de lucidez.

La expresión "representante legal" del caso debe entenderse en ese sentido.

V. SITUACIÓN DE VALENTINA

18. ¿Cuánto devengaba Valentina? ¿Ella o Amalia cuentan con pensión, ingresos propios o patrimonio que les permita costear parcialmente el cuidado domiciliario requerido?

- **Ingreso anterior de Valentina:** devengaba el equivalente a unos 18 salarios mínimos mensuales.
- **Ahorros:** entre 2023 y 2025 sus ahorros se destinaron a insumos, adecuaciones de la vivienda y horas parciales de cuidado privado. Hoy equivalen a unos dos meses de gastos básicos.
- **Pensión de Amalia:** recibe una pensión de jubilación docente equivalente a dos salarios mínimos. Esa pensión cubre los gastos del hogar.
- **Vivienda:** Amalia es propietaria de la vivienda donde ambas residen, que es su único bien.
- **Subsidio:** el hogar recibe un subsidio estatal por discapacidad severa equivalente a medio salario mínimo.
- **Costo del cuidador privado:** 16 horas diarias con un cuidador no profesional cuestan alrededor de 5 salarios mínimos mensuales. Con auxiliares de enfermería, el costo sube a unos 9.

19. ¿El diagnóstico de Síndrome del Cuidador Quemado de Valentina fue certificado por una entidad pública de salud mental o por su EPS?

En noviembre de 2025 lo diagnosticó la red de su EPS, en el régimen subsidiado:

- **Psiquiatría:** trastorno depresivo mayor, episodio moderado a grave.
- **Reumatología:** fibromialgia.
- **Evaluación de sobrecarga:** sobrecarga intensa en la escala de Zarit.

La historia clínica usa la expresión "síndrome del cuidador quemado" como denominación descriptiva. No es una categoría diagnóstica autónoma de la CIE-11.

No existe un dictamen de pérdida de capacidad laboral. El dictamen pericial ordenado por el Tribunal se practicará en la audiencia.

VI. EPS, COBERTURA Y ASPECTOS FISCALES

20. ¿A qué se refiere el término "disponibilidad de tiempo legal" usado por la EPS?

Es una expresión de la EPS y no un término definido en el derecho de Avelia. En la respuesta de la EPS, significa que Valentina no tiene un vínculo laboral ni otras personas a cargo que le impidan legalmente cumplir los deberes de socorro y alimentos hacia su ascendiente, previstos en el Código Civil.

El Código Civil de Avelia no define el contenido ni la intensidad horaria del cuidado personal entre descendientes y ascendientes.

21. ¿Cuál es el procedimiento para que se exceptúe la exclusión del pago de cuidadores por parte de la EPS?

No existe un procedimiento administrativo específico:

- La excepción de la Resolución 512 no está reglamentada (ver respuesta 9).
- Los comités técnico-científicos de las EPS no pueden autorizar servicios excluidos.
- La única vía utilizada ha sido la acción de tutela. En esa vía, algunos jueces de instancia ordenaron cuidadores de forma excepcional, pero la Corte Suprema no ha acogido esos criterios.

En cuanto a órdenes médicas: la médica tratante de la EPS dejó una nota en la historia clínica que respalda la necesidad de apoyo. No expidió una prescripción formal, porque el sistema no permite prescribir servicios excluidos. La exigencia de 16 horas proviene de la Junta Médica del Instituto.

22. ¿La cobertura estatal de centros de día y respiro familiar incluye el transporte de Amalia hasta el centro más cercano?

No. Se precisa lo siguiente:

- **Ubicación:** "localidad" se refiere a la división administrativa de la capital donde residen Amalia y Valentina.
- **Centro más cercano:** el centro de día público más cercano está en otra localidad, a unos 14 km, y tiene lista de espera.
- **Transporte:** el programa nacional no incluye transporte. La EPS solo cubre transporte para servicios de salud.

- **Admisión:** los centros de día no admiten personas con ventilación no invasiva ni con dependencia total.
- **Compatibilidad con el protocolo:** el componente de estimulación exige entorno doméstico, por lo que el centro de día no podría ejecutarlo.
- **Respiro:** no existe un programa estatal de respiro en funcionamiento.

23. ¿Cuál es el gasto o impacto fiscal que se menciona? ¿Consta en el expediente el costo estimado en términos comparables con el presupuesto de salud de Avelia?

Consta lo siguiente en el expediente:

- **Proyecto de Ley de Cuidados (2021):** el concepto del Ministerio de Hacienda estimó su costo en el 1,2% del PIB anual en régimen pleno, con implementación gradual a diez años. Como comparación, el gasto público en salud es del 6,5% del PIB. El concepto no analizó alternativas de menor alcance.
- **Costo individual:** está en la respuesta 18. Para 18 meses de protocolo, equivale a entre 90 y 162 salarios mínimos, según sea cuidado no profesional o de enfermería.
- **Argumento de la EPS:** la EPS alegó el posible "efecto demostración" de la orden sobre otros pacientes dependientes. No cuantificó ese efecto.

24. ¿Cuál es la prevalencia en el país de patologías como la de Amalia? ¿Existen estudios sobre qué porcentaje de esos pacientes requiere cuidados similares y quién los cubre?

- Según el Ministerio, unas 2.200 personas viven con ELA en Avelia.
- Cerca del 15% presenta demencia frontotemporal asociada.
- No hay un estudio oficial sobre cuántos pacientes requieren cuidados intensivos ni sobre quién los cubre.
- Una asociación de pacientes estima que la mayoría de los pacientes en fase avanzada depende de cuidadores familiares no remunerados, en su mayoría mujeres. Esa estimación no ha sido validada por el Estado.
- El protocolo Mnemósine admite como máximo 12 participantes.

VII. ASPECTOS PROCESALES

25. ¿La decisión de la Corte Suprema de Avelia del 14 de enero de 2026 admitía algún recurso posterior que no se ejerció?

No admitía recursos ordinarios. En Avelia la Corte Suprema es el órgano de cierre en materia de tutela.

Existía la posibilidad de un incidente de nulidad por violación del debido proceso, un remedio excepcional, que no se interpuso.

En su contestación, el Estado no presentó excepción de falta de agotamiento de recursos internos. El Tribunal ya declaró admisible el caso y la audiencia es de fondo. La objeción de competencia material que alegó el Estado sí puede debatirse.

26. ¿Cómo están operando las medidas cautelares ordenadas por el Tribunal? A la fecha de la audiencia, ¿el Estado las había cumplido total o parcialmente, o las había incumplido?

El Tribunal ordenó la medida el 20 de marzo de 2026. A la fecha de la audiencia el cumplimiento es parcial.

Medida (i), apoyo de cuidado domiciliario:

- Desde junio de 2026, el Ministerio ordenó a la EPS suministrar 8 horas diarias de auxiliar de enfermería domiciliaria, de lunes a viernes.
- Ha habido interrupciones y han rotado tres auxiliares distintos. Ninguno ha recibido la capacitación del protocolo.
- El Estado considera que esas 8 horas, junto con el apoyo familiar, son "suficientes".
- El Estado pidió al Tribunal modificar la medida, con base en el artículo 22 Ter.4 EB. Propone capacitar a Valentina y agregar un día semanal de respiro. El Tribunal no ha decidido esa solicitud.
- La Junta Médica consideró que 8 horas son insuficientes.
- El Instituto no ha programado la cirugía y fijó el **15 de diciembre de 2026** como fecha límite de elegibilidad.

Medida (ii), atención en salud a Valentina:

- Recibe psiquiatría mensual, psicoterapia quincenal y tratamiento para la fibromialgia.
- Ha habido demoras en la entrega de medicamentos.
- La historia clínica reporta una mejoría parcial.

Medida (iii), no regresividad:

- No se ha identificado una medida regresiva específica.
- En julio de 2026 el Gobierno presentó un nuevo Proyecto de Ley del Sistema Nacional de Cuidados. Está pendiente del primer debate y no tiene aval fiscal definitivo.

NOTA SOBRE FUENTES INTERNACIONALES ADICIONALES

Conforme al artículo 20 EB, el Tribunal aplica en primer lugar el Estatuto de Barcelona, luego los tratados y el derecho internacional de los derechos humanos, y de forma supletoria los principios generales del derecho.

La jurisprudencia de la Corte IDH tiene especial relevancia porque Avelia aceptó su competencia (ver respuesta 1). El valor vinculante de la OC-31/25 en el derecho interno es una cuestión debatible en el caso.

Las decisiones de otros sistemas pueden invocarse como criterio interpretativo y persuasivo, sin carácter vinculante para Avelia. A título enunciativo, y sin que ello limite la investigación de los equipos, se señalan las siguientes fuentes:

Sistema interamericano:

- Corte IDH, Poblete Vilches y otros vs. Chile (2018): salud de las personas mayores y consentimiento informado.

- Corte IDH, Cuscul Pivaral y otros vs. Guatemala (2018): progresividad y no regresividad.
- Corte IDH, Vera Rojas y otros vs. Chile (2021): cuidado domiciliario y deberes de aseguradores privados.
- Corte IDH, Guachalá Chimbo y otros vs. Ecuador (2021): discapacidad y consentimiento.
- Corte IDH, Furlan y familiares vs. Argentina (2012): discapacidad y plazo razonable.
- Corte IDH, I.V. vs. Bolivia (2016): consentimiento informado.
- Corte IDH, Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica (2012): progreso científico y autonomía.

Sistema europeo:

- TEDH, McDonald vs. Reino Unido (2014): reducción del cuidado nocturno y margen de apreciación.
- TEDH, Sentges vs. Países Bajos (2003) y Pentiacova y otros vs. Moldavia (2005): asignación de recursos sanitarios.
- TEDH, Hristozov y otros vs. Bulgaria (2012) y Durisotto vs. Italia (2014, decisión de inadmisibilidad): acceso a tratamientos experimentales.
- TEDH, Guberina vs. Croacia (2016): discriminación por asociación con persona con discapacidad.
- TJUE, Coleman (C-303/06, 2008): discriminación por asociación contra una cuidadora.
- Convenio de Oviedo (1997): consentimiento e investigación biomédica.

Sistema africano:

- Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, artículos 16 y 18.
- Protocolo a la Carta Africana sobre los Derechos de las Personas Mayores en África (2016).
- Comisión Africana, Purohit y Moore vs. Gambia (2003).

Sistema universal:

- Comité DESC: Observaciones Generales 3, 6, 14, 19 y 25 (esta última sobre ciencia y derechos económicos, sociales y culturales).
- Comité CDPD: Observaciones Generales 1 (capacidad jurídica y apoyos) y 5 (vida independiente).
- Comité CEDAW: Recomendación General 27 (mujeres de edad).
- Consejo de Derechos Humanos: Resolución 54/6 (2023) sobre la importancia de los cuidados y el apoyo desde una perspectiva de derechos humanos.
- UNESCO: Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos (2005) y Recomendación sobre la Ética de la Neurotecnología (2025).
- Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial y Pautas éticas internacionales CIOMS (2016).

Derecho comparado:

- Colombia: Corte Constitucional, sentencia SU-508 de 2020, sobre el servicio de cuidador.

- Chile: reforma constitucional sobre neuroderechos (2021) y Corte Suprema, caso Emotiv (2023).

Quedamos atentos a sus comentarios, los cuales pueden efectuar al celular 3106705426 y/o al correo electrónico cri@colderechomedico.com.

Suscriben:

MAICOL ANDRÉS RODRIGUEZ BOLAÑOZ
Coordinador de Relaciones Internacionales Colegio de Abogados en Derecho Médico

JHONY JAVIER ÑUSTES DUCUARA
Secretario del Colegio de Abogados en Derecho Médico